



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : عفاف عبدالعاطي احمد محمد
المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : العمرانية
رقم البطاقة : 27407272101501 رقم التليفون : 01140368855
العنوان : ~
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-07-1974 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عفاف عبدالعاطي احمد محمد National ID: 27407272101501	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient's Name: Afaf Abdel-Aaty Ahmed Mohammed
Date: 2026-05-30
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

INDICATION:

Left CBS

TECHNIQUE:

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral U/S

REPORT:

- Dense parenchyma, (ACR C), with focal disruption seen underlying the scar site at left breast.
- Right breast shows a central outer zone b circumscribed oval lesion of equal density. Complementary US revealed it to be a circumscribed oval isoechoic solid lesion seen at 8 O'clock measuring 10 mm.
- Left breast shows a LIQ circumscribed oval large lesion of mixed density. Complementary ultrasound revealed a complicated seroma measuring 8x7 cm.
- No suspicious lesions
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Right nonspecific axillary nodes are seen
- Free left axillary region as well as the infra and supra-clavicular regions.

OPINION:

- Right breast probably benign lesion likely fibroadenoma, (BIRADS 3).
- Right post-operative changes with complicated seroma, (BIRADS 2).

Best regards,
Dr. Yara Mohamed, MD

Name: عفاف عبدالعاطي احمد			
MR. : 3754			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
premenopausal met breast cancer to lung ,pleura triple negative by pleural cytology done in 11/2025 history left breast cancer luminal rec nact ac taxotere then lt bcs 15/1/2024 ypt2 ypn0 tamoxifen till 10/2025 ct chest bilateral pulmonary nodules ,left pleural eff for w1 taxol pharmacy visit : for w 6 taxol 160 mg wt 110 kg ht 161 cm bsa 2 MDT FOR TAXOL SINGLE AGENT FOR W7 ,8 TAXOL 145 MG (10% DR BEC OF GRADE 2 PN ,DIARRHEA) MBC TO LUNG AND PLEURA FOR TAXOL SINGLE AGENT FOR 9 AND 10 AND 11 145 MG FOR NEW ASSESSMENT BY CT Pharmacy Visit For week 10 Taxol 145 mg Labs 23/2 .. accepted for w12 taxol 145mg after labs w13 & w14 pharmacy *MRI brain 4/3/2026 (history of shunt) >> partial empty sella with prominent perri optic CSF spaces raising the possibility of benign ICT for neurology follow up *ct chest will be done CLINICL Pharmacy Visit: For week 13 Taxol 145 mg Labs OK pharmacy visit : week 14 taxol 145 mg labs ok wt : 110 kg, Ht: 161cm BSA: 2 TRIPLE NEG ,,METASTATIC BREAST CNCER TO LUNG AND PLEURA ,, 3/2026 MRI BRAIN :BENIGN INCREASE INTERACRANIAL TENSION . TODAY : W 15 (WITH DOSE RED 20%) (W16 + W 17). pharmacy visit :DR20% week 16 taxol 116mg labs ok6/4 SRCR 1.12 ct 16/3/2026 regression of left int mammary ln ,no pul nodules mild left pleural eff for w19 taxol115 ,w20,21 ph then new cts pt has grade 2 pn on supp tt cts pul nodules 8 mm left breast cystic lesion sm free cytology of left breast lesion pending for w22 taxol 105 mg w23 ph (10% dr) pt cc vertigo (history of shunt bec of idiopathic hydrocephalus 2004) for comparison of cts Pharmacy Visit For W 23 Taxol 115 mg Labs 21/6 ... accepted			
تحريرا في ,			
		التاريخ : 19-09-2026	
الوقت :		dina makram	
		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

ct13/6 comp newly developped left mild pleural effusion few pulmonary nodules 8 mm for mdt meanwhile continue taxol as no frank progression for w24 taxol 115

mdt on 23/7/2026 cts 6/2026 no significant pulmonary nodules or effusion maintain on femara based on primary pathology er 7/8 pr7/8 zometa /6 m evaluate every 3 weeks cytology weak evident to be considered for karar femara till app[roval for w27 taxol 110

7/2026 mdt : -CTs 6/2026 >> no significant pulmonary nodules or effusion -maintain on femara (hormonal assesment) -based on 1ry pathology of ER,PR 7/8 -Zometa / 6 months -evaluate every 3 onths by CT CAP -cytology weak evident to be considered femara +zometa +supportive

Name : Afaf Abdel-Aty Ahmed Mohammed
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 03-09-2026 02:32
Medical No. : 453846

NUCLEAR MEDICINE BONE SCAN REPORT

52-year-old female with left breast carcinoma, presenting with bony pain. Comparison with prior study dated August 15, 2023. Referred for follow-up skeletal evaluation.

Procedure: Whole-body planar bone scintigraphy, anterior and posterior views, following intravenous administration of 99mTc-MDP.

Findings:

- A small focal area of mildly increased tracer uptake is noted at the lower end of the left sacroiliac joint—indeterminate for early metastasis versus degenerative/inflammatory arthropathy.
- No other focal osteoblastic lesions are identified elsewhere in the skeleton.
- Persistent mild tracer uptake is noted in shoulders, knees, and dorso-lumbar spine, consistent with chronic degenerative changes (stable compared to prior study).
- Renal excretion is prompt and symmetric. No abnormal soft tissue uptake.

Impression:

- Newly seen indeterminate left sacroiliac uptake—differential includes early metastasis versus degenerative/inflammatory change, for radiological correlation to exclude metastatic possibility.
- No other definite skeletal lesions.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

R E T E N T I O N D I A G N O S T I C C E N T E R

Medical No. : 8742
Patient's Name: AfafAbdel-Aaty
Date: 2026-09-27
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



MRI EXAMINATION OF SACROILIAC JOINTS

Technique of examination:

Multi-planar multi-sequence MRI as per protocol.
No contrast was given..

Findings:

- Maintained normal articular relation of both sacroiliac joints.
- Small bilateral, patchy areas of peri-articular bone marrow edema of high T2/STIR signal are seen; at the opposing iliac and sacral articular surfaces bilaterally.
- No sizable synovitis or enthesitis.
- No significant erosions could be noted.
- No evident peri-articular fatty deposition.
- No evident bony fusion could be seen.
- Normal marrow signal of the examined bones.
- Normal MFR signal of the periarticular muscles.
- No peritarticular masses, collection or bursitis.
- Unremarkable pelvic organs.
- No pelvic masses, collection or adenopathy.

OPINION:

- Picture likely suggestive of mild degree bilateral inflammatory sacroiliitis; for clinical and laboratory correlation and follow up.

Best regards,
Dr. Abdulaziz Oraby, MD.
Lecturer of interventional and radio-diagnosis.